

## KOMMENTAAR

**Elen Preimann***hoolekande osakonna nõunik, sotsiaalministeerium*

Sotsiaalministeerium tellis praeguse erihoolekande ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste osutamise mudeli ning ISTE mudeli maksumuse võrdlemiseks mõjuanalüüsi. Civitta Eesti AS analüüsis toodi välja ühelt mudelilt teisele ülemineku hinnanguline kulu ja koostati nii praeguse kui ka ISTE järgi korraldatud erihoolekande kümne aasta teenusevajaduse eelarve prognoos.

Arvutused näitavad, et kui jätkata praeguse teenuste korraldusega, siis võib aastaks 2030 erihoolekandeteenuste saajate arv mõnevõrra väheneda, seda rahvaarvu üldise vähenemise tõttu. Sama võib eeldada ka uue mudeli puhul, kuid et ISTE võimaldab abivajajat paremini märgata, siis võib selle rakendamise korral teenuste kasutajate arv hoopis suureneda.

ISTE rakendamine võimaldab inimesel saada abi just nendes eluvaldkondades, kus ta seda vajab ja vastavalt oma toetuse vajadusele. Kuigi ISTE projektis on reaalsed kulud inimese kohta kuus olnud viimasel aastal keskmiselt 450 eurot, saadi mõjuanalüüsis ISTE hinnanguliseks keskmiseks kuluks kuus 1537 eurot (projektis osalenud KOVide ja teenuseosutajate hinnangute põhjal). Analüüsi autorite sõnul on põhjus selles, et teenuseosutajad kalduvad abivajadust üle hindama. Samuti ei teadvustata tõsisja, et inimeste võimalused komponente kasutada on väga erinevad: alati ei ole sobivaid spetsialiste, suure teenusmahu korral tekivad logistilised ja komponentide omavahelise suhestumise küsimused.

Mõjuanalüüsi koostajad rõhutavad, et kui ISTE võetakse laiemalt kasutusele, siis tuleb:

- määrata teenusemahutule toetusvajaduse astmest olenevad ülempiirid, mis võimaldaks olemasolevat raha jaotada võimalikult paljude abivajajate vahel;
- lihtsustada KOVide administratiivset tööd (vähem dokumentatsiooni, andmeid mugavamalt esitada võimaldav infosüsteem);
- panna paika erihoolekande taristuga seotud strateegilised eesmärgid ja selle alusel arvestada rahastamisel ka amortisatsiooni, mis aitab tagada teenuseosutajate tegevuse jätkusuutlikkuse.

Kui jätkatakse praeguse erihoolekande teenusemudeliga, soovitatakse:

- diferentseerida teenuste hindu toetuse vajaduse alusel. Praegu toetatakse mõningatel juhtudel suurema abivajadusega inimesi väiksema abivajadusega inimeste arvelt;
- välistada mitmel teenusel korraga olevale inimesele teenuste dubleerimise;
- võimaldada suuremat diferentseeritust ühe teenuse sees, näiteks toetusvajaduse astme alusel.

Praeguse erihoolekandeteenuste osutamise mudeli ning uue isikukeskse teenusemudeli maksumuse mõjuanalüüsi kohaselt oleks uue, komponendipõhise teenusmudeli järgi korraldatud süsteem küll oluliselt kallim, kuid vastaks paremini inimeste vajadustele.

Aasta lõpuks valmib sotsiaalministeeriumis väljatöötamiskavatsus, kus teeme mõjuanalüüsi põhjal järeldusi ja ettepanekuid, kuidas edasi minna. Seda, kas, kuidas ja millal ISTE-le üle minnakse, ei saa veel öelda.

Loe mõjuanalüüsist pikemalt Sotsiaaltöö veebis avaldatud artiklist.